

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0276

Paginas del documento: 8

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

eta ou indiretamente reveladora ou severa que poderia afetar expectativas de futuro e visão da vida.

Dessa forma, entende-se que a má notícia, que pode ser desde um diagnóstico de hipertensão arterial até o comunicado do falecimento de um familiar, apresenta gradação subjetiva e particular quanto ao impacto nos receptores da informação. Nesse contexto, a preparação dos profissionais de saúde no processo de comunicação permite conter danos psicoemocionais no paciente, na família e mesmo em quem tem a responsabilidade de comunicar².

O capítulo V, artigo 34, do Código de Ética Médica de 2019³ refere que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Com isso, entende-se que, muitas vezes, a dificuldade não está na dúvida ética entre comunicar a verdade ou não, mas em como fazê-lo: quais palavras escolher, que postura adotar e como manter a empatia e humanidade sem afetar a resposta profissional que o momento exige. Ante essas questões, percebe-se por que o ato de comunicar más notícias é um dos mais estressantes e dificultosos no exercício profissional na área da saúde⁴.

Diante de uma má notícia, o que logo se apresenta com clareza para o paciente é a necessidade de reconfigurar sua rotina e revisar seus planos imediatos. As incertezas e inseguranças suscitadas pelo diagnóstico e tratamento prenunciam a instalação de um quadro de crise, permeado por intensa fragilidade emocional. A nova realidade desencadeia no paciente reações de luto antecipado pelo fim da vida que vinha levando até o momento do adoecimento e pela perspectiva sombria de que talvez não consiga realizar sonhos e projetos futuros ou continuar investindo no desenvolvimento dos projetos presentes⁵.

Dessa forma, o profissional encarregado de transmitir o diagnóstico deve estar preparado para assumir uma postura simultaneamente ativa – no sentido de oferecer informações dosificadas e de acordo com a necessidade do momento – e empática – de modo a acolher o sofrimento

pelo paciente, do acolhimento proporcionado pelo profissional de saúde, o que não somente contribui para amenizar o impacto do diagnóstico como também auxilia no posterior ajustamento do paciente à situação de tratamento e reabilitação psicossocial.

A habilidade de comunicação é passível de ser ensinada, e, de fato, a simples experiência, desacompanhada de treinamento efetivo, dificilmente será capaz de melhorá-la¹⁰. Na comparação com outros países, nota-se que, a despeito de o Brasil ser o único a ensinar “acolhimento”, o treinamento formal em habilidades de comunicação médica ocupa espaço inferior nas escolas médicas que o aplicam formalmente no currículo¹¹.

Assim, o despreparo para mediar situações que requeiram tais habilidades começa na formação médica e resulta em condutas heterogêneas que poderiam ser evitadas com melhor treinamento durante a graduação¹². Nesse contexto, a criação de protocolos de comunicação de más notícias visou estabelecer técnicas adequadas para atenuar o impacto negativo no momento de comunicá-las. Esses protocolos se provaram cientificamente eficazes em diminuir o estresse do profissional de saúde e melhorar suas habilidades de comunicação, na medida em que lhe propiciam transmitir a informação de forma humana e realista, além de fortalecer a relação médico-paciente-família e aumentar a adesão e confiança no tratamento¹³.

Considerando o contexto supracitado, este artigo busca avaliar se a técnica de comunicação de más notícias é abordada durante a graduação médica. Além disso, tem como ponto-chave a análise do conhecimento e das limitações dos discentes no que diz respeito à comunicação de más notícias, com base nos dados obtidos da aplicação de questionário padronizado.

Método

Trata-se de estudo transversal, de natureza básica, com objetivo descritivo e delineado como levantamento baseado em dados primários obtidos por meio de questionário. A amostra foi composta

mbro de 2022 e junho de 2023, encontravam-se no 11º semestre mestre. Aos respectivos representantes de turma, foi enviado um *link* de formulário eletrônico criado na ferramenta Google Forms para ser redirecionado nas redes sociais das turmas, o qual continha um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e o questionário eletrônico a ser preenchido.

O instrumento utilizado neste estudo para avaliar o cenário do ensino médico em comunicação de más notícias foi traduzido e adaptado, pelos autores, da publicação original do protocolo SPIKES¹⁴. Das 13 perguntas originais, nove foram mantidas e quatro foram excluídas por direcionarem-se especificamente à validação do protocolo e, portanto, fugirem do escopo deste trabalho. Além disso, foram adicionadas duas perguntas com aspectos sociodemográficos (1 e 10), a fim de caracterizar a amostra.

O questionário foi convertido ao formato de planilha pela ferramenta Google Planilhas, e os dados foram analisados por meio do *software R*, com o teste exato de Fisher sendo utilizado para avaliar a associação entre as variáveis, considerando o nível de significância em 5% ($p < 0,05$).

Resultados

O instrumento de análise do ensino da comunicação de más notícias foi preenchido por 57 discentes. Destes, três foram excluídos por terem sido retornados após a interrupção do período de coleta, de forma que 54 questionários foram analisados. Quanto à distribuição entre os sexos, a amostra é predominantemente feminina (53,7%), mas sem diferença estatística ($p > 0,05$); 81,4% dos alunos da amostra encontram-se no 11º semestre; e a idade média da amostra é de 25,16 anos, com mediana de 25 anos e desvio padrão de 3,97 (Tabela 1).

A análise dos resultados mostra que 46,2% dos discentes informaram que não tiveram, durante a graduação, cenário de prática que possibilitasse a comunicação de más notícias. A mesma proporção de participantes referiu que nunca comunicou

Característica	Descrição
Idade média (mín.-máx.)	25,16 (21-49)
Sexo, n (%)	
Masculino	25 (46,2%)
Feminino	29 (53,7%)
Semestre, n (%)	
11º semestre	44 (81,4%)
12º semestre	10 (18,5%)

A tarefa considerada mais difícil, elencada por 50% dos alunos, é a discussão de questões de fim de vida, seguida por comunicação do fim do tratamento ativo e início do tratamento paliativo, com 22,2%. Entre os discentes, 55,5% haviam acompanhado outros profissionais durante a transmissão de notícias ruins; 33,3% não tinham tido nenhuma formação e/ou treinamento para essa situação; e 11% tinham algum tipo de preparo formal.

Em relação à autopercepção da qualidade de suas comunicações, 59,25% definiram a própria comunicação como razoável; 22,22%, como ruim; 9,25%, como boa; 7,4%, como muito ruim ou péssima; e 1,85% como muito boa. No que diz respeito à maior dificuldade no processo de transmitir uma má notícia, 44,4% dos alunos consideraram que lidar com a emoção do paciente é o aspecto mais complexo, e 25,9% que é ser honesto e ao mesmo tempo preservar a esperança do doente. Ademais, 75,8% da amostra alegou que não se sente muito confortável (59,2%) ou sente-se absolutamente desconfortável (16,6%) ao ter que responder às emoções dos pacientes. Ainda assim, 50% não têm nenhum tipo de treinamento para responder às emoções dos pacientes, e 40,7% acompanharam outros profissionais nesse processo.

Todos os participantes acreditam que ter uma estratégia ou abordagem para comunicar seria útil na prática diária, entretanto 37% não conhecem nenhum protocolo de comunicação de más notícias. Entre os 29 discentes que já comunicaram más notícias, independentemente da frequência, 51,7% utilizaram várias técnicas ou táticas e nenhum plano global; 31% não utilizaram nenhuma abordagem consistente; e 17,2% utilizaram um plano ou estratégia cons-

Item do questionário	Total		n (%) (n=54)
	Masculino (n=25)	Feminino (n=29)	
1. Durante a graduação você teve cenário de prática que possibilitou a comunicação de más notícias?			
Sim	13 (24,0%)	16 (29,6%)	29 (53,7%)
Não	12 (22,2%)	13 (24,0%)	25 (46,2%)
2. Em um mês, quantas vezes você comunica más notícias?			
Nunca comuniquei	10 (18,5%)	15 (27,7%)	25 (46,2%)
Menos de 5 vezes	14 (25,9%)	13 (24%)	27 (50,0%)
5 a 10 vezes	1 (1,8%)	1 (1,8%)	2 (3,7%)
11 a 20 vezes	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Mais de 20 vezes	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
3. Qual tarefa você considera mais difícil?			
Discutir o diagnóstico	4 (7,4%)	1 (1,8%)	5 (9,2%)
Informar ao paciente a recorrência da doença	1 (1,8%)	3 (5,6%)	4 (7,4%)
Falar sobre fim do tratamento ativo e início do paliativo	6 (11,1%)	6 (11,1%)	12 (22,2%)
Discutir questões de fim de vida	12 (22,2%)	15 (27,7%)	27 (50,0%)
Envolver a família/amigos	2 (3,7%)	4 (7,4%)	6 (11,1%)
4. Que tipo de formação ou treinamento você recebeu para transmitir más notícias?			
Formal: treinamento, curso ou especialização	1 (1,8%)	2 (3,7%)	3 (5,5%)
Acompanhou médico ou outro profissional da saúde	14 (25,9%)	16 (29,6%)	30 (55,5%)
Ambos	1 (1,8%)	2 (3,7%)	3 (5,5%)
Nenhum	9 (16,6%)	9 (16,6%)	18 (33,3%)
5. Como você avalia sua própria capacidade de dar más notícias?			
Muito boa	0 (0,0%)	1 (1,8%)	1 (1,8%)
Boa	2 (3,7%)	3 (5,5%)	5 (9,2%)
Razoável	17 (31,4%)	15 (27,7%)	32 (59,2%)
Ruim	4 (7,4%)	8 (14,8%)	12 (22,2%)
Muito ruim ou péssima	2 (3,7%)	2 (3,7%)	4 (7,4%)
6. Para você, o que é mais difícil ao discutir a má notícia?			
Ser honesto, sem tirar a esperança	7 (12,9%)	7 (12,9%)	14 (25,9%)
Lidar com a emoção do paciente (choro, raiva...)	10 (18,5%)	14 (25,9%)	24 (44,4%)
Decidir o tempo de permanência com o paciente	2 (3,7%)	5 (9,2%)	7 (12,9%)
Conversar/envolver familiares e amigos do paciente	4 (7,4%)	3 (5,5%)	7 (12,9%)
Envolver o paciente e/ou a família nas decisões	2 (3,7%)	0 (0,0%)	2 (3,7%)
7. Que tipo de treinamento técnico você recebeu para responder às emoções do paciente?			
Formal: treinamento, curso ou especialização	0 (0,0%)	2 (3,7%)	2 (3,7%)
Acompanhou médico ou outro profissional da saúde	12 (22,2%)	10 (18,5%)	22 (40,7%)
Ambos	1 (1,8%)	2 (3,7%)	3 (5,5%)
Nenhum	12 (22,2%)	15 (27,7%)	27 (50,0%)
8. Como você classificaria o seu próprio conforto em lidar com as emoções do paciente?			
Bastante confortável	1 (1,8%)	0 (0,0%)	1 (1,8%)
Confortável	4 (7,4%)	8 (14,8%)	12 (22,2%)
Não muito confortável	16 (29,6%)	16 (29,6%)	32 (59,2%)
Absolutamente desconfortável	4 (7,4%)	5 (9,2%)	9 (16,6%)

Item do questionário	Masculino (n=25)	Feminino (n=29)	n (%) (n=54)
ou abordagem para comunicar más notícias pode ser útil em sua prática?			
Sim	25 (46,2%)	29 (53,7%)	54 (100%)
Não	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
10. Você conhece algum protocolo de comunicação de más notícias? (Caso necessário, marque mais de uma alternativa.)			
SPIKES	12 (22,2%)	20 (37,0%)	32 (59,2%)
PACIENTE	2 (3,7%)	3 (5,5%)	5 (9,2%)
Outro	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Nenhum	12 (22,2%)	8 (14,8%)	20 (37,0%)
11. Ao comunicar má notícia ao paciente, que plano ou estratégia você utiliza?			
Nunca comuniquei	10 (18,5%)	15 (27,7%)	25 (46,2%)
Um plano ou estratégia consciente	0 (0,0%)	5 (9,2%)	5 (9,2%)
Várias técnicas, mas sem nenhum plano global	10 (18,5%)	5 (9,2%)	15 (27,7%)
Nenhuma abordagem consistente à tarefa	5 (9,2%)	4 (7,4%)	9 (16,6%)

A autopercepção dos alunos sobre a qualidade de suas comunicações não apresentou correlação com a oferta ou não, na graduação, de cenário que possibilitasse a comunicação de más notícias ($p=0,5235$) ou com o tipo de formação e/ou treinamento ($p=0,468$). O impacto das diferenças entre os sexos nos diversos aspectos da comunicação não foi objeto de análise neste estudo.

Discussão

No Brasil, apesar de as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Medicina enfatizarem a relevância da comunicação como competência a ser bem desenvolvida pelos graduandos, o texto é superficial no que se refere à importância da habilidade na relação médico/paciente/familiar. O próprio Conselho Nacional de Educação corrigiu parcialmente essa deficiência ao publicar a Resolução CNE/CES 4/2001¹⁵, que estabelece competências e habilidades necessárias ao futuro médico. Contudo, dados sobre a implementação dessas medidas ainda são escassos.

Do grupo de acadêmicos entrevistados, 46,2% afirmaram que não houve oferta de cenário de prática para comunicar más notícias, dado paradoxal ao que é exigido na prática médica. Ademais, entre os alunos que tiveram acesso a algum cenário de

r más notícias como “boa” ou to é prejudicial na medida em el que o profissional se mostre seguro em relação à notícia e ao modo de prosseguir para que o paciente e seus familiares também sintam segurança, a fim de estabelecer uma boa relação médico-paciente e, com isso, obter melhor adesão ao tratamento proposto ou aceitação da condição permanente²⁰.

Dada a importância da comunicação de más notícias no dia a dia dos médicos, as técnicas de ensino são um tema importante e devem ser priorizadas na educação médica, de modo a preparar os estudantes de medicina para uma atuação mais humanizada¹⁰. Não existe um método que sirva para todas as situações; a maneira de transferir uma má notícia varia de acordo com a idade, o sexo, o contexto cultural, social e educacional, a doença que o acomete e o contexto familiar do paciente¹². Dessa forma, a adequação cultural e social dos diversos protocolos e estratégias de ensino deve ser assegurada por parte das instituições de ensino,

faz com que os pacientes se sintam melhores, a adesão ao tratamento aumente, o manejo da dor seja melhor e o prognóstico de doenças crônicas e sintomas diminuam¹⁰.

Considerações finais

Este estudo demonstrou que o ensino em comunicação de más notícias é um tema subvalorizado na educação médica, haja vista que 46,2% dos alunos entrevistados não tiveram cenário de prática para comunicação, 33,3% não tiveram nenhum tipo de treinamento e, dos que tiveram, 75% relataram ter tido apenas experiências informais e observacionais. Com isso, evidencia-se uma realidade preocupante no ensino médico acerca do treinamento de uma habilidade rotineira e essencial à prática clínica. Há a necessidade de ampliação da amostra e das escolas médicas avaliadas para que o debate sobre o tema seja ampliado e melhorias sejam efetivadas.

Referências

 0000-0002-7124-4534

 0009-0008-8090-5921

 0009-0001-6772-2660

 0009-0000-7209-0656

 0009-0009-0121-5330

 0000-0001-8954-4212

Robson Gabriel Xavier Pinheiro – Hospital Universitário João de Barros Barreto, Rua dos Mundurucus, 4.487, Guamá
CEP 66073000. Belém/PA, Brasil.

Participação dos autores

Robson Gabriel Xavier Pinheiro e Luis Felipe Ferreira Carneiro fizeram parte da idealização, análise de dados e redação do manuscrito. Amanda Gabriele Alves Cobiniano de Melo, Fernanda Oliveira de Oliveira e Mayara de Andrade Moratto realizaram a coleta e organização dos dados. Williams Fernandes Barra foi o responsável pela orientação e revisão crítica final do manuscrito. Todos os autores revisaram o manuscrito.

Recebido: 2.6.2024

Revisado: 6.1.2025

Aprovado: 20.1.2025